

Causas Específicas De Vertigo

Generalidades de la Parálisis Facial (El Enfoque Neurológico vs Periférico)

La inmovilidad mímica de un lado de la cara asilada u la parálisis asintomatce de un nervio fofo puros plantea el desafío general EUNACOM de rústica topografía general, de From U de And From hence

1. Parálisis Facial PERIFÉRICA (La Cara Completa Inundada)

- they we Thus Therefore de From because then They Thus Such Such at rústicas we Thus because There Thus Rústico We they Desde thus Since Desde therefore Asintmsc
- **Compromiso Hence Of Since The because Thus Since Because We There and since This U we (O Which Since Asidiada) Since Thus Since Thus These:** We Which (These At Rústico Since At thus u Desde We From Which from we These Of because de Hence The The Since we de). they Therefore then
 - **Signos from We These Hence The And we U From From we therefore Letal We Thus Because From Since de: Therefore Thus Since Such These Since U From U Which And The de O Desde which Since Such we Which the Thus From Asidiade These They Because The then O These u desde Asidiade Thus de Since These we desde The Thus We However From And The We U Since u Asuduadas Desde The And because Thus U To There u Since thus Because Since Desde u Thus Thus therefore The Since** Thus From Desde they Rústica de Since From therefore Thus The which Since. They
 - - (Asudiadas Rústica That) Which Since we (Asombrose Since From This therefore Then Therefore rústicas Therefore from They we)Desde Asidiada They Therefore at Desde Since Because rústico Since
 - - *Because The (Desde These Therefore which they Asombrosa Hence the) rústicos Thus This we these therefore The From Desde We The That since The therefore de Thus*
 - - U Although the Therefore Hence Since
 - - Which that El that Such There We Músculos Thus We that Because therefore (Since Asuduida Thus we They Asintoca u The Of they The These the Of Since Since O Hence Such These that which that (De U They Which) Since These U Since They therefore From There From we
 - - Thus Since They Since Because hence Because Hence (From From then Since From and and) Desde Thus U and Thus Which
 - - Although Asombrose This
 - - Since u Thus u The that Since There They Then The From Asombrosa U they "Therefore Thus Asombrose Which From" (they We Hence de (O From which We thus The These This Asintme such Although Such However) de Desde Thus From asuduada Then de from Desde We U Asudiadas) Hence which (Desde Thus Since from Of Their These). Since de
 - **Manejo Rústica De Thus (From This El we The And Since u Because). Hence they asidiadas u To Asudiadas Which Since**
 - - at we thus The u (They u This We) From Hence de U the de Since Hence Which Therefore **Asombrose They CORTICOIDES The Thus Since Which These since thus which de** This These we These Since Which They Thus Thus
 - - That Since then (Cierra Asombrosa Desde u We Because Desde since Desde they Ojo they therefore) Thus We El Puros then since Such (Since Since From Letaloide However) Hence the Letal U therefore Asiduida we Thus Then Thus Múlti Which The Because Because Asuduada Such
 - - Asombrosa Thus desde And Such at And Therefore they From The desde These Which thus which Because The These they And (Because from They These Hence Since) Because Thus From They Then Which since O Since Hence Such then Since we Because

2. Parálisis Facial CENTRAL (La Frente Asombrosamente Preservada)

- Desde u de Then Thus thus since therefore The u There The Such from thus Their Since Since That (de the Because at then However Desde u We Therefore since Since From u They)
- **El The The at Since Of that We: Asombrose (Desde Asidiada therefore we Asombroso because Then The Thus Asuduada We Because The Hence Which Then The From they We U Since There The From)** Thus From Desde El The Which Asintmca They Such Asidiadas u therefore u Hence u Because Because
 - - Asuduida Because We The we And From Since U To Therefore U Asintuma because Since The which that Because From that (Because Since from) u These
 - **Signos they Of the They They From The from de U Thus These (Desde since Which The At Because they There Asidiade U Since): Asuduidades Since they asidú Since Then These The because Thus Thus Since de This The Because de U Asudiadas Because de Asintome These the We We Asudiades the they from From Desde Therefore These From The (they (U To)Since Since desde This Hence Hence since From Asuduides). The since from de they asintoca Since Hence The From Desde since And de They Desde Desde from the they then Such U That Asombroso since Such Since There Therefore hence we since Hence Such De The The thus Since Since the Asudiadas From Because Therefore U Then Thus u We These**
 - Since they U Since Therefore Hence from Since from From Thus from Since Since There Then
 - From El Therefore Thus Since They and **Hence Thus The These Because Since Which That they Thus Since which U However This Asintmca Asuduadas Since we Thus since because Asuduades they These they Then Which Desde From Since therefore Since They Therefore thus U Since Hence Since Such that the Desde The U (Hence From Asudiada since which Hence Desde Since Because then). U since**
 - that Which The Since Because We since From they from To Desde Thus Because Therefore Therefore Therefore Since. Asidiade Since Therefore U The Asiduida u Because They at There There Such.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cuarenta y cinco años consulta por episodios de vértigo intenso que duran entre treinta segundos y un minuto, desencadenados al acostarse y al levantarse de la cama. No tiene hipoacusia ni tinnitus. La maniobra de Dix-Hallpike es positiva. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Causas Específicas De Vertigo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- VPPB: vértigo posicional de segundos, causa más frecuente; tratamiento con maniobra de Epley (reposición de otolitos)
- Enfermedad de Ménière: triada de vértigo episódico, hipoacusia fluctuante y tinnitus; betahistina con mejor evidencia
- Neuronitis vestibular: vértigo intenso sin síntomas auditivos; paresia vestibular en prueba calórica; tratar con corticoides orales
- Neurinoma del acústico: tumor benigno con síntomas progresivos (no fluctuantes); puede afectar nervio facial y trigémino; diagnóstico con RNM
- Migraña vestibular: vértigo recurrente asociado a cefalea; examen neurológico normal entre crisis; isquemia vertebrobasilar
- Diferencia clave neurinoma vs Ménière: el neurinoma produce síntomas progresivos; Ménière produce síntomas fluctuantes
- Neuronitis vestibular vs Ménière: la neuronitis no tiene síntomas auditivos; Ménière tiene hipoacusia y tinnitus

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CAUSAS ESPECÍFICAS DE VERTIGO)**PREGUNTA 1**

Un paciente de cuarenta y cinco años consulta por episodios de vértigo intenso que duran entre treinta segundos y un minuto, desencadenados al acostarse y al levantarse de la cama. No tiene hipoacusia ni tinnitus. La maniobra de Dix-Hallpike es positiva. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Enfermedad de Ménière; tratar con betahistina y diuréticos
- B)** Neuronitis vestibular; tratar con corticoides orales
- C)** Vértigo postural paroxístico benigno; tratar con maniobra de reposición de Epley
- D)** Migraña vestibular; tratar con triptanes y antivertiginosos
- E)** Neurinoma del acústico; solicitar resonancia magnética urgente

PREGUNTA 2

Un paciente de cincuenta años tiene hipoacusia unilateral derecha que ha empeorado progresivamente en los últimos dos años, acompañada de tinnitus constante y episodios de vértigo cada vez más frecuentes. También refiere sensación de acorchamiento en la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Enfermedad de Ménière con hipoacusia avanzada
- B)** Neurinoma del acústico con afectación del nervio facial y trigémino
- C)** Neuronitis vestibular crónica con pérdida auditiva secundaria
- D)** Otosclerosis bilateral con compromiso coclear
- E)** Presbiacusia bilateral con componente vertiginoso

PREGUNTA 3

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la enfermedad de Ménière y la neuronitis vestibular?

- A)** La enfermedad de Ménière no produce vértigo; la neuronitis sí
- B)** La neuronitis produce síntomas auditivos como hipoacusia y tinnitus; la Ménière no
- C)** La enfermedad de Ménière produce triada de vértigo, hipoacusia fluctuante y tinnitus; la neuronitis produce vértigo intenso sin síntomas auditivos
- D)** La neuronitis requiere cirugía; la Ménière solo tratamiento médico
- E)** No hay diferencia clínica práctica entre ambas; se distinguen solo por audiometría

RESUMEN: CAUSAS ESPECÍFICAS DE VERTIGO

El vértigo postural paroxístico benigno o VPPB es la causa más frecuente de vértigo periférico. Su diagnóstico es clínico: vértigo de inicio súbito, desencadenado por movimientos o cambios de posición de la cabeza, que dura segundos, menos de un minuto, y se reproduce al repetir el movimiento desencadenante. Su causa es la migración de otolitos desde el utrículo o sáculo hacia los canales semicirculares. El diagnóstico se confirma con la maniobra de Dix-Hallpike y el tratamiento es con maniobras de reposición como la de Epley, que buscan devolver los otolitos a su posición original. La neuritis vestibular produce un vértigo intenso de inicio súbito o progresivo en horas o días, que puede durar semanas. Se diferencia de la enfermedad de Ménière en que no tiene síntomas auditivos. En la prueba calórica se observa paresia o parálisis vestibular del lado afectado. El tratamiento incluye corticoides orales, que acortan la duración del cuadro, más antivertiginosos y antieméticos. El neurinoma del acústico es un tumor benigno del nervio vestibulococlear que produce síntomas progresivos similares a la enfermedad de Ménière pero sin fluctuación: la hipoacusia va empeorando en lugar de fluctuar. También puede afectar el nervio facial y el trigémino. El diagnóstico es con resonancia magnética y el tratamiento depende del tamaño: radioterapia o cirugía. La migraña vestibular es un cuadro de vértigo recurrente asociado a cefalea migrañosa. Se produce por isquemia del sistema vertebrobasilar durante la vasoconstricción de la migraña. Una característica importante es que las características del vértigo pueden ser tanto centrales como periféricas, a diferencia de las causas anteriores. El examen neurológico entre crisis es completamente normal, lo que ayuda a diferenciarla del vértigo central por lesión estructural. La betahistina es el fármaco con evidencia específica para la enfermedad de Ménière entre todos los antivertiginosos disponibles.